

Gaming *Disorder*

ICD-11 6C51 — zaburzenie związane z grami. Nie chodzi o liczbę godzin, chodzi o funkcjonowanie. E-sportowiec gra 8h i ma świetne życie; nastolatek gra 4h i przestał wychodzić z pokoju.

CZAS CZYTANIA: 15 min Diagnostyka różnicowa **ŹRÓDŁO:** WHO ICD-11 (2018); King & Delfabbro (2019)

JAK UŻYWAĆ

1 · Poznaj trzy kryteria ICD-11 (sekcja 01) — kontrola, priorytet, konsekwencje, utrzymywane co najmniej 12 miesięcy. **2** · Zrozum, dlaczego *czas sam w sobie nie jest kryterium* (sekcja 02) — i sprawdź funkcjonowanie zamiast liczyć godziny. **3** · Poznaj gatunki gier o najwyższym ryzyku (sekcja 03). **4** · Sprawdź współwystępowanie — 50-80% osób z GD ma zaburzenie towarzyszące, które trzeba leczyć równolegle (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Zaburzenie związane z grami (ang. *Gaming Disorder*, ICD-11 6C51) zostało wprowadzone przez WHO w 2018 r. po latach kontrowersji. Saunders i wsp. (2017) i Mihara & Higuchi (2017) wykazali, że spełnia kryteria pełnoprawnego zaburzenia — z mechanizmem nagrody podobnym do hazardu, ale bez stawek finansowych. **1-9% graczy** spełnia kryteria, zależnie od metodologii (King & Delfabbro 2019). Czynniki ryzyka: płeć męska, adolescencja, ADHD, depresja, lęk społeczny, niska samoocena. Kluczowa różnica względem hazardu: *granie samo w sobie* jest aktywnością neutralną — dla większości pozytywną. To dopiero *utrata kontroli + konsekwencje funkcjonalne* czynią je zaburzeniem. WHO celowo nie wprowadziło kryterium godzinowego — bo „dużo grania” bez konsekwencji to nie zaburzenie, a „mało grania” z konsekwencjami funkcjonalnymi może już nim być. Aarseth i wsp. (2017) ostrzegali przed *moralną paniką* — diagnoza nie może opierać się na opiniach rodziców o „za dużo gier”.

01 📖 Trzy kryteria ICD-11 — wszystkie muszą wystąpić

1 · UTRATA KONTROLI

początek, częstotliwość, czas, koniec
„Próbowałem grać mniej i nie udało się.” Sesja planowana na godzinę kończy się po pięciu. Nieskuteczne próby ograniczenia. *Pytanie diagnostyczne:* „Ile razy w ostatnim półroczu udało Ci się grać mniej, niż planowałeś?”

2 · PRIORYTET

granie nad innymi sferami
Granie staje się ważniejsze niż szkoła, praca, sen, jedzenie, kontakty offline, higiena. *Pytanie:* „Czy zdarzyło Ci się odwołać spotkanie z bliskimi / opuścić zajęcia / nie spać, żeby grać?”

3 · KONSEKWENCJE + 12 MC

eskalacja mimo szkód
Granie powoduje realne szkody (oceny, praca, relacje, zdrowie) — a mimo to *nie zmniejszasz*. Wzorzec utrzymuje się co najmniej **12 miesięcy** (krócej tylko przy ciężkim nasileniu).

02 ☹️ Czas grania ≠ diagnoza

Najczęstszy błąd: liczenie godzin. WHO celowo nie wprowadziło kryterium godzinowego. Liczy się **funkcjonowanie** — nie czas.

PRZYKŁAD 1 · DUŻO GRANIA BEZ PROBLEMU

E-sportowiec gra **8 godzin dziennie**. Ma kontrakt, pieniądze, sen 8h, partnerkę, trenuje fizycznie, je regularnie. To jego *praca* — nie zaburzenie. **GD: nie.**

PRZYKŁAD 2 · MNIEJ GRANIA, ALE SZKODY

Nastolatek gra **4 godziny dziennie**. Oceny spadły z piątek na trójki, śpi 4h, nie wychodzi z pokoju, nie kąpie się, schudł 10 kg. Przy próbie ograniczenia — agresja. **GD: tak.**

03 Gatunki gier o najwyższym ryzyku

Nie wszystkie gry są tak samo ryzykowne. Najwyższe ryzyko: gry z **otwartym końcem**, **zmiennym wzmocnieniem** i **elementem społecznym**.

MMORPG

np. World of Warcraft

Brak końca, gildia (zobowiązania społeczne), zmienne nagrody (loot), wydarzenia czasowe (FOMO).

BATTLE ROYALE

np. Fortnite, PUBG

Krótkie cykle 15–30 min, sezony, ranking, mikrotransakcje, lootboxy, presja rówieśników.

MOBA

np. League of Legends

Rozgrywki 30–60 min, ranking, drużyna („nie mogę zostawić”), toksyczność społeczności.

NISKIE RYZYKO

single-player, puzzle, fabularne

Mają *koniec*, brak presji społecznej, brak zmiennych nagród. Pyt.: „Która gra jest Twoim głównym problemem?”

04 Współwystępowanie — gaming bywa objawem, nie przyczyną

50-80% osób spełniających kryteria GD ma współwystępujące zaburzenie (Mihara & Higuchi 2017). Gaming bywa *strategią radzenia sobie* z czymś innym. Sprawdź, co u Ciebie.

CZY GRAM, BY UCIEC OD CZEGOŚ?

— stres, smutek, nuda, samotność, lęk społeczny

CO REALNY ŚWIAT OFERUJE MI GORZEJ NIŻ GRA?

— osiągnięcia, kontakt, kontrola, flow

NAJCZĘSTSZE WSPÓŁWYSTĘPOWANIA W GD

- ☐ **Depresja** — granie jako ucieczka od pustki, gra daje krótką ulgę
- ☐ **Lęk społeczny** — gra jako bezpieczna przestrzeń kontaktu, „przyjaciele tylko online”
- ☐ **ADHD** — gry oferują natychmiastowe nagrody, których brak w nauce / pracy
- ☐ **ASD (spektrum autyzmu)** — struktura, przewidywalność zasad, brak niejednoznaczności społecznej
- ☐ **Trauma / PTSD** — gra jako dysocjacja od ciała i bolesnych wspomnień

Klucz: nie diagnozuj GD na podstawie godzin. Pytaj o *funkcjonowanie* — sen, jedzenie, higiena, oceny / praca, relacje offline, aktywność fizyczna. Jeśli to wszystko działa — granie *nie jest* problemem klinicznym, choćby było intensywne. Jeśli któryś z obszarów się sypie i utrzymuje się to ≥ 12 miesięcy — to GD niezależnie od liczby godzin. **Nie zabieraj gier jako pierwszej interwencji** (to nie działa) — najpierw zrozum funkcję grania, potem buduj alternatywne źródła nagrody, dopiero potem negocjuj limity (King & Delfabbro 2019).